

Québec	20 septembre 2011
Région :	Mauricie—Centre-du-Québec
Dossier :	430165-04-1102
Dossier CSST :	135983047
Commissaire :	Martin Racine, juge administratif
Membres :	Guy-Paul Hardy, associations d'employeurs Serge Saint-Pierre, associations syndicales

Luc Bouchard
Partie intéressée

DÉCISION

[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 8 septembre 2011 en présence des parties qui sont représentées. L'affaire est mise en délibéré le même jour.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n'a pas droit à la réadaptation professionnelle vu l'absence d'atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et qu'il est capable d'exercer son emploi le 29 avril 2010.

L'AVIS DES MEMBRES

[5] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête de l'employeur doit être rejetée puisque la preuve démontre l'existence de limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle du travailleur.

[6] En effet, ils sont d'opinion que le médecin désigné par l'employeur a énoncé des limitations fonctionnelles et que le médecin qui a charge du travailleur a indiqué être d'accord avec cette conclusion. Selon les membres, malgré que le travailleur ne se soit pas vu attribuer un déficit anatomo-physiologique indemnisable, il a le droit de bénéficier de la réadaptation en raison de la présence de limitations fonctionnelles permanentes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit à la réadaptation professionnelle à la suite de la lésion professionnelle qu'il a subie le 16 décembre 2009.

[8] À cet égard, il ressort du dossier que la CSST a accepté la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle, tel qu'il ressort d'une note évolutive rédigée le 10 février 2010 par l'agent de la CSST qui indique que la tendinite du biceps gauche est présumée être une maladie professionnelle en raison de l'application de l'article 29 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi).

[9] Une analyse effectuée par le médecin régional de la CSST le même jour conclut à la relation « médicalement possible » entre les fonctions de désosseur de veaux à la table que le travailleur exerce depuis plus de deux mois et les mouvements qu'il est amenés à effectuer dans le cadre de ce travail.

[10] Cette analyse de la docteure Line Lemay, contient les éléments suivants :

¹ L.R.Q., c. A-3.001.

Titre : Analyse en MP

- ASPECT MÉDICAL :

Tendinite biceps G

- Considérant que le travailleur occupe le même poste depuis plus de 2 mois,
- Considérant que le travailleur est droitier mais celui-ci travaille avec les 2 mains,
- Considérant que lors du désossage, il effectue des mouvements de flexion-abduction plus grands que 40° du bras gauche pour aider au désossage en dégageant la viande, l'os, le gras, etc, avec effort,
- Considérant la cadence continue,
- Considérant les postures contraignantes statiques possibles,
- Considérant que le travailleur travaille au froid,
- Considérant que les temps de repos sont peu importants.

La relation est médicalement possible.

[11] La décision de la CSST acceptant la réclamation du travailleur n'a pas fait l'objet d'une contestation.

[12] Le 4 mai 2010, la CSST rend une nouvelle décision dans laquelle elle conclut, après l'étude du dossier, qu'un nouveau diagnostic de névrite cubitale gauche n'est pas relié avec « l'événement du 16 décembre 2009 ». Elle informe toutefois les parties que le travailleur continue de recevoir des indemnités en raison de sa tendinite du biceps gauche.

[13] La preuve, qui consiste exclusivement dans le dossier constitué par le tribunal, puisque les parties se sont limitées à présenter une argumentation à l'audience, révèle que le travailleur a été pris en charge par le docteur Richard Dubois qui a prescrit un arrêt de travail et des traitements de physiothérapie.

[14] Le 14 avril 2010, le docteur Dubois complète un rapport médical dans lequel il pose notamment un diagnostic de tendinopathie de l'épaule gauche. Il indique que la période prévisible de consolidation de la lésion est de plus de 60 jours.

[15] C'est dans ce contexte que le travailleur est examiné à la demande de l'employeur, le 29 avril 2010, par le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste. Dans une expertise qu'il complète le même jour, le docteur Gilbert note que la douleur à l'épaule gauche est rapportée « toujours dans le cadre d'une lésion de nature professionnelle et l'approche thérapeutique est toujours la même ». Il ajoute que la CSST a accepté la réclamation du travailleur.

[16] Toutefois, après avoir révisé le dossier et examiné le travailleur, le docteur Gilbert indique dans sa discussion qu'il est en présence d'une personne qui « présente des manifestations douloureuses au niveau de l'épaule dont je ne peux préciser

l'étiologie précise étant donné que les tests spécifiques de la coiffe des rotateurs sont peu significatifs ».

[17] Le docteur Gilbert est d'avis que la lésion à l'épaule gauche est une algie sans manifestation clinique pouvant orienter vers une pathologie spécifique. C'est ce qui l'amène à conclure que le travailleur ne présente pas une « lésion de nature professionnelle » :

Pour établir une relation causale, il faut avoir un diagnostic précis. Or, la normalité de mon évaluation et la recherche des signes spécifiques d'une atteinte de l'épaule gauche (syndrome de buté acromiale) s'étant toutes avérées négatives, je me retrouve avec un statut musculosquelettique cliniquement normal. Dans cette optique, et en prenant pour acquis la description des tâches qu'effectuait monsieur Bouchard, je ne crois pas que l'on puisse être en présence d'une lésion de nature professionnelle.

En effet, le dépôt des pièces sur le convoyeur nécessite une projection antérieure de l'épaule et non pas des mouvements d'abduction et cette projection antérieure ne dépasse pas les 35 à 40°. Dans cette optique, la relation causale m'apparaît inacceptable.

Il se pourrait fort bien que ce déclic ne soit sans aucune signification et provienne du labrum, mais il me fallait définitivement avoir, pour ce patient, une évaluation radiologique. Or celle-ci met en évidence une minime arthrose acromio-claviculaire sans plus. [sic]

[18] Le docteur Gilbert énonce ainsi les conclusions de son expertise :

1. **Diagnostic :**
Algie de l'épaule gauche sans manifestation clinique nous orientant vers une pathologie spécifique.
2. **Date de consolidation :**
Le 29 avril 2010.
3. **Traitements :**
Nil
4. **Atteinte permanente :**
Aucune
5. **Limitations fonctionnelles :**
Aucune
6. **Relation causale**
Aucune.
7. **Possibilité d'une atteinte permanente**
Aucune d'identifiée selon le questionnaire et les évaluations radiologiques.

8. **Possibilité de faire son travail régulier ou de faire un travail avec restrictions**

Je recommande de réintégrer ce patient à un travail en limitant les projections antérieures au-delà de 80° ou les mouvements d'abduction dépassant les 45°.

[19] Le 13 mai 2010, l'employeur transmet à la CSST l'expertise du docteur Gilbert et l'informe de son désir de contester le rapport du docteur Dubois : « Nous contestons les points 1, 2, 3 de l'article 212 de la loi et nous demandons au Bureau d'évaluation médicale de statuer sur les points 4 et 5 du même article ».

[20] Cette expertise est acheminée au médecin qui a charge du travailleur, le docteur Dubois, qui signe le 25 mai 2010 un rapport complémentaire dans lequel il lui est demandé d'expliquer les raisons pour lesquelles il maintient ou modifie son opinion en ce qui a trait au diagnostic, à la date de consolidation et à la nécessité de soins.

[21] Dans un premier temps, il appert qu'il indique être d'accord avec les conclusions du docteur Gilbert en ce qui a trait à ces trois sujets. Il précise qu'il était dans l'attente de l'opinion du chirurgien à qui le travailleur avait été référé, le docteur Mario Pelletier. Le docteur Dubois indique que son patient n'a pas été avisé de la teneur de son rapport.

[22] Cependant, le 1^{er} juin 2010, le docteur Dubois inscrit une nouvelle note manuscrite sur le rapport complémentaire précité dans lequel il mentionne ce qui suit : « Oui d'accord avec conclusions ».

[23] Le 2 juin 2010, le médecin régional de la CSST, la docteure Line Lemay, transmet la demande suivant au docteur Dubois :

Vous avez mentionné être en accord avec le diagnostic, la consolidation et les traitements indiqués sur le rapport complémentaire. Pourriez-vous nous préciser si vous êtes en accord ou non avec les conclusions du Dr André Gilbert concernant l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[24] Le 15 juin 2010, le docteur Dubois répond sur le formulaire d'informations médicales complémentaires écrites ce qui suit : « Oui, d'accord avec conclusions Dr André Gilbert ».

[25] Dans une note manuscrite inscrite sur un formulaire de rapport complémentaire, il est inscrit que le dossier ne sera pas transmis au Bureau d'évaluation médicale étant donné la teneur de l'opinion du docteur Dubois.

[26] C'est ainsi que la CSST rend, le 9 septembre 2010, une décision concernant la réadaptation. Elle informe le travailleur qu'il peut bénéficier de la « réadaptation

professionnelle, puisque vous conservez des limitations fonctionnelles attribuables à votre lésion professionnelle survenue le 16 décembre 2009 ».

[27] Elle indique également que l'évaluation de la situation laisse entrevoir qu'il aura besoin de service de réadaptation pour pouvoir retourner au travail et qu'elle poursuit le versement de l'indemnité de remplacement du revenu et entreprend de rechercher, avec lui-même et son employeur, des solutions qui conviennent le mieux compte tenu des circonstances. Une évaluation du poste de travail est prévue.

[28] C'est cette décision que l'employeur a contestée.

[29] Dans une argumentation écrite déjà soumise à la CSST à laquelle le représentant de l'employeur réfère à l'audience, il prétend qu'il résulte de tous les commentaires du docteur Dubois que le travailleur ne présente pas d'atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle puisqu'il se déclare d'accord avec l'opinion du docteur Gilbert. Ainsi, le travailleur ne peut bénéficier de la réadaptation professionnelle. De plus, il ajoute qu'en vertu de l'article 145 de la loi, un travailleur porteur de limitations fonctionnelles ne peut bénéficier de la réadaptation en l'absence d'atteinte permanente.

[30] Enfin, selon l'employeur, le docteur André Gilbert n'a reconnu aucune limitation fonctionnelle et ses commentaires concernant la possibilité pour le travailleur de faire son travail régulier ou un travail avec restrictions constituent une réponse à « d'autres questions d'ordre médical et de nature administrative qui ne concerne pas les sujets médicaux liant de l'article 212 LATMP ». À son avis, il va de soi que la réponse à la question que lui posait l'employeur n'a « aucun lien avec les sujet médicaux de l'article 212 et par conséquent ne sont pas liant pour la CSST. La réintégration au travail n'est pas un sujet médical liant pour la CSST ». [sic]

[31] Il soumet ce qui suit en ce qui a trait à la recommandation du docteur Gilbert :

La recommandation du Dr. Gilbert est tout au plus une recommandation de nature préventive d'ordre général qui peut s'appliquer à tout travailleur, victime ou non d'une lésion professionnelle. Jamais, dans le rapport du Docteur. Gilbert, il n'est dit que le travailleur est incapable de faire des projections antérieures au-delà de 80° et jamais il n'est dit que le travailleur est incapable de faire des mouvements d'abduction dépassant les 45°.

Cette recommandation telle que formulée ne saurait permettre de conclure que le travailleurs a des limitations fonctionnelles et encore moins, qu'il est atteint de façon permanente dans son intégrité physique. En fait, le Dr. Gilbert ne constate pas la présence d'une incapacité physique du travailleur d'accomplir certaines tâches.

La jurisprudence, de façon unanime a défini ce que sont l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. Aussi, les limitations fonctionnelles se distinguent des

séquelles fonctionnelles qui, elles, font partie de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.

Les séquelles fonctionnelles décrivent une anomalie, une restriction ou une réduction au niveau de la fonction caractéristique d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan physique, physiologique ou anatomique, à la suite d'une lésion professionnelle.

Les limitations fonctionnelles décrivent une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique de se comporter ou d'accomplir une activité quotidienne, personnelle ou professionnelle d'une façon ou dans les limites considérées normales en raison d'une lésion professionnelle. [sic]

[32] À l'audience, le représentant de l'employeur ajoute qu'il est inéquitable pour l'employeur que la CSST n'ait pris en compte que la dernière partie de l'opinion du docteur Gilbert et qu'elle aurait dû normalement reconsidérer la décision initiale sur l'admissibilité de la lésion considérant que le docteur Dubois s'est déclaré d'accord avec le diagnostic retenu par le docteur Gilbert. De plus, il est d'avis que la CSST aurait pu demander au docteur Gilbert des précisions quant à la portée de son opinion.

[33] Par ailleurs, il reconnaît qu'il est possible, dans certaines circonstances, que des limitations fonctionnelles soient reconnues sans atteinte permanente et que cela peut donner accès à la réadaptation, mais à condition que ces limitations fonctionnelles découlent d'un diagnostic relié à la lésion professionnelle, ce qui n'est pas le cas en son avis.

Analyse

[34] Afin de disposer de la contestation de l'employeur, le tribunal doit déterminer dans un premier temps si la lésion professionnelle du travailleur entraîne des limitations fonctionnelles. Par la suite, il y aura lieu, le cas échéant, de déterminer si la condition du travailleur lui donne droit à la réadaptation professionnelle, tel qu'en a décidé la CSST.

[35] La notion de limitation fonctionnelle n'est pas définie à la loi. Toutefois, la jurisprudence a eu à se pencher, à de nombreuses reprises, sur sa portée, notamment dans le contexte où il s'agissait de décider s'il était possible de retenir des limitations fonctionnelles même en l'absence d'atteinte permanente à l'intégrité physique pouvant être indemnisée en fonction du *Règlement sur le barème des dommages corporels*² (le barème).

² (1987) 119 G.O. II, 5576.

[36] À cet égard, le tribunal fait siens les propos du juge administratif Lamarre qui fait un bon résumé du droit applicable dans l'affaire *Courcelles et Aliments Conagra Canada inc.*³ :

[44] D'autre part, comme elle l'a fait dans le passé, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il y a lieu de distinguer les notions de séquelles fonctionnelles et de limitations fonctionnelles. Ainsi, dans la cause *Richard et Fabspec inc.*², la Commission des lésions professionnelles fait la distinction entre ces deux notions. Quant à la séquelle fonctionnelle, elle consiste en une anomalie, une restriction ou une réduction de la fonction caractéristique d'un organe, d'une structure anatomique ou d'un système par rapport à ce qui est considéré normal au plan anatomique, physiologique ou psychique, et qui découle d'une lésion professionnelle. La limitation fonctionnelle se traduit plutôt par une restriction ou une réduction de la capacité physique ou psychique du travailleur à accomplir normalement une activité quotidienne de nature personnelle ou professionnelle en raison de la lésion professionnelle.

[45] La commissaire Marquis précise que l'octroi de limitations fonctionnelles n'est pas subordonné à l'existence de séquelles fonctionnelles compensables suivant le *Règlement sur le barème des dommages corporels*. Le travailleur, dont la lésion professionnelle n'a pas entraîné de déficit fonctionnel objectivable aux plans neurologique et articulaire, peut se voir reconnaître des limitations fonctionnelles si la preuve médicale démontre l'existence de séquelles susceptibles de le restreindre dans sa capacité à accomplir normalement ses activités quotidiennes.

[46] Ainsi, comme elle l'a fait à maintes reprises dans le passé, la Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il est possible de conclure à la présence de limitations fonctionnelles même en l'absence de séquelles fonctionnelles lorsqu'une preuve probante le supporte. En outre, la jurisprudence a reconnu que, dans certains cas, la présence de séquelles douloureuses en l'absence d'une atteinte permanente peut justifier l'octroi de limitations fonctionnelles³, lorsque, par exemple, elles sont décrites de façon constante et de la même manière aux différents examinateurs et que la bonne foi du travailleur ne peut être remise en question. Il a également déjà été décidé que des limitations fonctionnelles peuvent être accordées également à des fins préventives en l'absence de séquelles objectivées lorsque, de façon probante, il est démontré que celles-ci découlent bien de la lésion et que le travailleur demeure plus susceptible de présenter des récidives, rechutes ou aggravations de sa lésion en raison de ses antécédents ou de ses caractéristiques personnelles⁴.

² [1998] C.L.P., 1043

³ *Blanchette et Cie d'échantillon National ltée*, 236942-64-0406, 06-04-21, J.-F. Martel; *Nadeau et Multi-Do*, 186534-03B-0206, 02-12-19, M. Cusson; *Pavage CSF inc. et Salvo*, 278253-71-0512, 07-03-21, F. Juteau; *Boulevard Dodge Chrysler Jeep 2000 et Bevilacqua*, 207397-72-0305, 04-02-26, Anne Vaillancourt; *Automobiles Val Estrie et Tanguay*, 271538-05-0509, 07-03-07, M. Allard; *Hydroserre Mirabel inc. et Chaillou*, C.L.P., 300345-64-0609, 2008-01-09, R. Napert.

⁴ *Poitras et Béton de Demix Longueuil*, C.L.P. 107184-31-9811, 7 avril 1999, M.-A. Jobidon; *Air Canada et Schanck*, [1998] C.L.P. 11.; *Tessier et Scobus (1992) inc.*, C.A.L.P. 59353-62-9405, 24 octobre 1995, M. Lamarre; *Chénard et Sœurs du Bon Pasteur de Québec*, C.L.P., 323579-31-0707, 18 février 2008, M. Racine.

³ C.L.P. 313864-61-0704, 17 juin 2008, M. Lamarre.

[37] En l'espèce, le tribunal est d'avis que, pour déterminer si le docteur Gilbert a retenu des limitations fonctionnelles, il y a lieu d'examiner l'ensemble de son expertise avec laquelle le médecin qui a charge du travailleur s'est déclaré d'accord et qu'il n'est pas opportun de se limiter à ce qu'il a écrit sous la rubrique limitations fonctionnelles.

[38] Étant donné que son expertise a été rédigée dans le cadre de la procédure d'évaluation médicale prévu à la loi, il y a lieu de prendre en compte, pour saisir la portée de l'opinion d'un médecin, de tous les commentaires de nature médicale qu'on peut y retrouver.

[39] Or, en l'espèce, le docteur Gilbert ne s'est pas limité à exprimer son avis sur les cinq sujets énumérés au premier alinéa de l'article 212 de la loi. En effet, tel que lui avait demandé l'employeur, il s'est exprimé aussi sur « la relation causale ». Tel qu'il appert de l'extrait reproduit plus haut, dans lequel ce médecin fait valoir, en prenant compte de la condition du travailleur et la description de ses tâches, qu'il « ne croit pas que l'on puisse être en présence d'une lésion de nature professionnelle ». Il ajoute aussi que la relation causale lui « apparaît inacceptable ».

[40] Ces commentaires donnent un éclairage sur la façon dont le docteur Gilbert s'exprime dans son expertise lorsqu'il indique qu'il n'y a aucune limitation fonctionnelle. Or, tel que mentionné précédemment, la lésion professionnelle du travailleur a été reconnue à titre de maladie professionnelle. Cependant, ce même médecin, répondant à un questionnement relatif à la possibilité pour le travailleur de réintégrer son travail ou « un travail avec restrictions », recommande le retour dans un travail « en limitant les projections antérieures au-delà de 80° ou les mouvements d'abduction dépassant les 45° ».

[41] Pour le tribunal, une telle énonciation de restrictions correspond en tout point à la notion de « limitation fonctionnelle » élaborée par la jurisprudence précitée et le fait qu'elle n'apparaisse pas sous la rubrique « limitation fonctionnelle » de l'expertise n'a aucune incidence sur la nature et la portée des propos du docteur Gilbert.

[42] En effet, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme n'ayant pas sa place en matière d'indemnisation des lésions professionnelles. D'ailleurs, l'article 351 de la loi énonce que les décisions doivent être rendues suivant l'équité et d'après le mérite réel et la justice du cas, l'article 353, prévoyant de son côté, qu'aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour un vice de fond ou irrégularité.

[43] C'est ainsi que le tribunal considère qu'il ressort d'une lecture complète de l'expertise du docteur Gilbert que ce médecin est d'avis que la condition médicale du travailleur fait en sorte qu'il ne doit pas effectuer un travail nécessitant des projections antérieures au-delà de 80° ou des mouvements d'abduction dépassant les 45°. Il s'agit

à n'en pas douter d'une restriction de la capacité physique du travailleur à accomplir une activité professionnelle, que la preuve au dossier relie à sa lésion professionnelle.

[44] Dans ce contexte, la CSST est devenue liée par l'avis du médecin du travailleur entérinant la conclusion du médecin désigné par l'employeur sur l'existence de limitations fonctionnelles comme l'a confirmé la jurisprudence à maintes reprises. C'est ce qu'il ressort notamment des propos du juge administratif Clément⁴ :

[43] Le docteur Cliche aurait pu décider de ne pas remplir un tel rapport tout comme il aurait pu décider de s'en tenir à sa position initiale. Il a toutefois plutôt décidé de se rallier au diagnostic du docteur Fradet, à savoir une entorse lombo-sacrée. Il écartait par le fait même le diagnostic qu'il avait émis dans son rapport final de hernie discale L4-L5 droite.

[44] Comme il se ralliait au diagnostic du docteur Fradet, il n'y avait plus lieu d'acheminer le dossier au Bureau d'évaluation médicale puisque cette instance vise à trancher des litiges existant entre les médecins de l'employeur et du travailleur et non pas à se prononcer lorsqu'il y a unanimité et absence de divergence. Cette référence au Bureau d'évaluation médicale vise à trancher des litiges et non à en créer.

[45] L'effet liant de l'avis émis par le médecin qui a charge dans un rapport complémentaire a été reconnu à de nombreuses reprises par la jurisprudence. Ainsi, dans l'affaire *Lagueux et Maisons mobiles de Thetford*⁷, la Commission des lésions professionnelles décidait que la CSST était liée par les allégations et conclusions du médecin du travailleur contenues dans un rapport médical complémentaire en l'absence de preuve que le médecin avait été indûment influencé.

[46] Dans l'affaire *Briceus et Teinturiers Concorde*⁸, il fut décidé que la CSST pouvait, en vertu de l'article 204, demander à un médecin d'examiner le travailleur et faire part de son rapport au médecin du travailleur à la suite de cet examen. L'article 205.1 permet à la CSST d'agir ainsi et encourage le médecin du travailleur à exprimer son opinion lors de la réception d'un tel rapport. La CSST devient liée par l'avis du médecin du travailleur entérinant les conclusions du médecin désigné. Ces principes ont été repris dans d'autres décisions⁹. Il faut cependant que la réponse du médecin du travailleur à l'avis du médecin désigné par la CSST soit clair, ce qui est le cas en l'espèce¹⁰. Aucune preuve d'erreur du docteur Cliche n'a été portée à l'attention du tribunal. Il apparaît plutôt que ce dernier s'est rallié aux arguments du docteur Fradet.

[47] La jurisprudence a aussi reconnu que l'article 205.1, bien que donnant l'occasion au médecin qui a charge d'étayer sa position s'il la maintenait pour référence au Bureau d'évaluation médicale, n'empêchait pas ce dernier de se déclarer d'accord avec le médecin désigné par la CSST ou l'employeur ou encore d'apporter d'autres conclusions totalement différentes¹¹. Ainsi, en date du 5 septembre 2003, le diagnostic au dossier n'était plus que celui d'entorse lombo-sacrée puisque c'était là l'opinion du docteur Marcel Cliche, médecin qui a charge du travailleur, laquelle lie la CSST et le présent tribunal au sens de l'article 224 de la Loi :

⁴ *Fortin et Société Groupe Emb. Pepsi Canada*, C.L.P. 229370-09-0403, 8 juin 2004, J.-F. Clément.

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

⁷ C.L.P. 94938-03B-9803, 11 mars 1999, P. Brazeau.

⁸ C.L.P. 105960-72-9810, 8 février 1999, L. Boudreault.

⁹ *Grignano et Récital Jeans inc.*, [2000] C.L.P. 329; *Lussier et Berlines RCL inc.*, C.L.P. 122844-05-9908, 21 septembre 2000, L. Boudreault; *Boissonneault et Costco Ste-Foy Division (Entrepôt)*, C.L.P. 190343-32-0209, 4 février 2003, G. Tardif; *Balouzian et 3D Micro Ordinateurs Canada inc.*, C.L.P. 176381-61-0201, 26 décembre 2002, D. Beauregard; *Lacombe et Novexcel inc.*, C.L.P. 172763-62C-1111, 8 juillet 2002, N. Tremblay; *Hébert et Dépanneur FG*, C.L.P. 179207-04-0202, 14 mai 2002, J.-F. Clément; *Sasseville et Entreprises Claude Doré inc.*, C.L.P. 167626-02-0108, 4 décembre 2001, C. Bérubé.

¹⁰ *Ferguson et Ind. de moulage Politech inc.*, C.L.P. 155516-62B-0102, 3 octobre 2001, A. Vaillancourt; *Morin et 2970-0374 Québec inc.*, C.L.P. 135078-08-0003, 9 octobre 2001, L. Boudreault; *Fox et C.S. South Shore*, C.L.P. 152348-62A-0012, 22 mars 2002, N. Tremblay, révision rejetée, 25 juin 2003, N. Lacroix.

¹¹ *Guillemette et Kruger inc.*, C.L.P. 162565-09-0106, 17 janvier 2002, Y. Vigneault.;

[45] Par ailleurs, le tribunal est d'avis que l'accord du médecin qui a charge quant au diagnostic ne devait pas nécessairement amener la CSST à reconsidérer sa décision d'acceptation de la lésion professionnelle.

[46] D'une part, l'employeur ne l'a pas demandé et, d'autre part, il est loin d'être certain que ce nouveau diagnostic puisse être assimilé à la présence d'une erreur ou d'un fait essentiel auquel réfère l'article 365 de la loi, dans le contexte où la réclamation du travailleur a été acceptée en fonction d'un diagnostic non contesté, à l'époque, soit une tendinite.

[47] Par ailleurs, comme il a été décidé à de nombreuses reprises, le tribunal est d'avis que les limitations fonctionnelles permanentes constituent en espèce une atteinte à l'intégrité physique du travailleur qui fait en sorte que celui-ci a droit à la réadaptation prévue à la loi⁵.

[48] En effet, les limitations fonctionnelles découlant d'une lésion professionnelle qui empêchent un travailleur de reprendre son travail normal impliquent nécessairement la présence de séquelles et par conséquent, d'une atteinte permanente à l'intégrité physique.

⁵ *Morel et Santé Routier inc.*, [1988] C.A.L.P. 528; *Lessard et Centrale Sécurité ltée*, C.A.L.P. 05265-60-8711, 17 août 1990, S. Lemire; *Roy et Bétonel ltée*, [1991] C.A.L.P. 426; *Côté et Autobus Deux Montagnes*, C.A.L.P. 65129-64-8412, 12 juillet 1996, A. Archambault; *Rebuts Solides Canadiens inc. et Nadeau*, C.L.P. 180759-62C-0203, 18 décembre 2002, M. Sauvé.

[49] C'est ce que rappelle notre collègue Di Pasquale⁶ dans une affaire où la lésion professionnelle n'avait causé aucun déficit anatomo-physiologique au travailleur :

[49] Donc, la CSST a rendu sa décision concernant la capacité du travailleur à reprendre son travail à partir de renseignements erronés. D'une part, le docteur Kerner lui avait fait dire au téléphone par sa secrétaire que le travailleur ne conserverait pas de séquelles permanentes alors que dans son rapport il indique que le travailleur ne pourra pas soulever de poids de plus de 4 kg, ce qui constitue une limitation fonctionnelle. D'autre part, l'employeur avait dit, à l'agente qui a rendu la décision, que le travailleur effectuait son travail régulier alors que ce n'est pas ce que la preuve révèle.

[50] La preuve révèle plutôt que le travailleur n'a jamais repris son travail régulier, qu'il est incapable de refaire ce travail car il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles. En effet, le travailleur ne doit pas soulever de charges de plus de 4 kg dans l'exécution de ses tâches. Par conséquent, il ne pourra pas reprendre son travail de boucher.

[51] L'article 47 de la loi prévoit que le travailleur dont la lésion est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable.

[52] L'article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique a droit à la réadaptation que requiert son état.

[53] C'est donc l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique qui donne ouverture au droit à la réadaptation. Cependant, la jurisprudence reconnaît que même en l'absence d'une atteinte permanente quantifiable en vertu du barème, un travailleur peut bénéficier des dispositions de la réadaptation s'il présente des limitations fonctionnelles permanentes l'empêchant de reprendre son emploi. En effet, cette jurisprudence a clairement établi que la présence ou l'absence de limitations est un élément objectif pertinent pour déterminer si l'état du travailleur requiert des mesures de réadaptation en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. Cette notion de limitation fonctionnelle est entièrement liée à la notion de capacité à exercer un emploi et doit être considérée pour évaluer les besoins d'un travailleur en réadaptation.

[54] Dans l'affaire *Guillemette et Bureau de Placement d'Anjou inc.*, le commissaire Jean-François Martel écrit :

64. Ainsi les limitations fonctionnelles reconnues par le docteur Jackson comme résultant de la lésion professionnelle forment ici l'unique mesure pertinente de la réadaptation que requiert l'état de la travailleuse en vue de réintégrer son emploi prélésionnel; c'est en regard de celles-ci seulement que l'on doit par conséquent évaluer sa capacité à l'exercer.

⁶

Mackeen et Aliments Edelweiss inc., C.L.P. 213161-61-0306, 19 avril 2004, S. Di Pasquale.

[55] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état.

⁴ *Tessier et Scobus (1992) inc.*, [1995] C.A.L.P. 1487; *Général Motors du Canada ltée et Trottier*, C.A.L.P. 87519-61-9704, 27 novembre 1997, L. Thibault, révision rejetée, 25 juin 1998, A. Archambault; *Ouellet et Québec-O-Chimie inc.*, C.A.L.P. 45950-01-9211, 15 mai 1995, M. Lamarre, (J7-04-36)

⁵ 2003], C.L.P. 781, révision pendante.

[50] C'est ce qui l'amène à conclure que le travailleur a droit à la réadaptation puisqu'il conserve des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle. Cette décision a été reprise avec approbation à plusieurs reprises.

[51] Dans une affaire récente⁷, notre collègue Bouvier écrit :

[30] Le droit à la réadaptation, à la suite d'une lésion professionnelle, repose sur la présence d'une atteinte permanente. Dans le cadre de cette disposition, la notion d'atteinte permanente ne se limite pas uniquement à la présence d'un déficit anatomophysiologique, mais comprend également les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle³ puisque celles-ci constituent un élément objectif permettant d'évaluer les besoins que requiert l'état du travailleur⁴.

³ *Landry et Centre d'accueil Émilie Gamelin* [1995] C.A.L.P. 1049; *Deroy et Pentagon Construction 1969*, C.A.L.P. 79693-60-9606, 17 mars 1997, F. Dion-Drapeau.

⁴ *Mackeen et Aliments Edelweiss inc.*, C.L.P. 213161-61-0307, 19 avril 2004, S. Di Pasquale.

[52] La juge administrative Lizotte⁸ est aussi du même avis :

[44] La jurisprudence considère que la présence de limitations fonctionnelles tout comme l'existence d'un déficit anatomophysiologique donnent ouverture à la réadaptation³. La réadaptation physique, sociale et professionnelle sont autant de volets couverts par le chapitre de la réadaptation contenu à la loi.

³ *Mackeen et Aliments Edelweiss inc.*, C.L.P. 213161-61-0307, 19 avril 2004, S. Di Pasquale.

[53] En l'espèce, puisque les limitations fonctionnelles concernent spécifiquement des mouvements devant être évités au travail, le tribunal se doit de conclure que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état. Sa capacité à exercer son emploi doit, comme l'a décidé la CSST, être déterminée en fonction des exigences de son emploi.

[54] C'est ce qui fait que la CSST était justifiée de rendre la décision initiale du 9 septembre 2010 qui a été confirmée par la révision administrative.

⁷ 2011 QCCLP 1008.

⁸ 2011 QCCLP 3276.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Montpak International inc. (l'employeur);

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 février 2011, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Luc Bouchard (le travailleur) a droit à la réadaptation professionnelle.

Martin Racine

Me Jacques Bélanger
ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO
Représentant de la partie requérante

Madame Stéphanie Boisvert
S.C.E.P. – SECTION LOCALE 145
Représentante de la partie intéressée

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Québec 13 octobre 2011

Région : Mauricie–Centre-du-Québec

Dossier : 430165-04-1102-C

Dossier CSST : 135983047

Commissaire : Martin Racine, juge administratif

Montpak International inc.
Partie requérante

et

Luc Bouchard
Partie intéressée

RECTIFICATION D'UNE DÉCISION

[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 20 septembre 2011, une décision dans le présent dossier;

[2] Cette décision contient une erreur d'écriture qu'il y a lieu de rectifier en vertu de l'article 429.55 de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*, L.R.Q., c. A-3.001;

[3] Au paragraphe 42, nous lisons :

En effet, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme n'ayant pas sa place en matière d'indemnisation des lésions professionnelles. D'ailleurs, l'article 351 de la loi énonce que les décisions doivent être rendues suivant l'équité et d'après le mérite réel et la justice du cas, l'article 353, prévoyant de son côté, qu'aucune

procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour un vice de fond ou irrégularité.

[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

En effet, il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme n'ayant pas sa place en matière d'indemnisation des lésions professionnelles. D'ailleurs, l'article 351 de la loi énonce que les décisions doivent être rendues suivant l'équité et d'après le mérite réel et la justice du cas, l'article 353, prévoyant de son côté, qu'aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour un vice de forme ou irrégularité.

Martin Racine

Me Jacques Bélanger
ROBINSON, SHEPPARD, SHAPIRO
Représentant de la partie requérante

Madame Stéphanie Boisvert
S.C.E.P. – SECTION LOCALE 145
Représentante de la partie intéressée